随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·大肠癌

（性感认识：把握不同手术指征）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现和检查

1.**中老年排便习惯和粪便性状改变**（**最早、最常见**的症状），**便血**（最主要的报警症状）

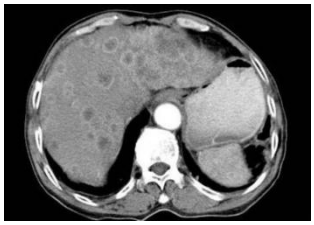
2.病理

①腺癌多见

②淋巴转移最早最常见

③晚期血道转移最常至**肝→牛眼征**（边缘明显环形强化）

④**伴肝、肺、腹股沟淋巴转移：可能同时手术（预后好）**



异质性
亚克隆

边缘血供丰富 通过门V

e.g 一个转移灶/三个转移灶,刚好局限在肝脏的某一段或某一叶

3.检查 ttsx

①**首选：直肠指检**（70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物）

②**金标准：结肠镜**

③CEA（癌胚抗原）：判断预后、监测复发、辅助诊断。CEA 与肿瘤分期有关；术后 CEA 未明显下降可提示肿瘤残留；术后 CEA 持续升高可提示肿瘤复发

分期靠后:放出来CEA多

④大便隐血试验：筛查（可持续阳性）胃癌:大便隐血试验筛查

⑤**CT/MRI、腔内超声、超声内镜：明确局部浸润、转移等以分期**

看浸润深度,助分期

4.术前肠道准备：预防性用抗生素，术前 **2-3** 天进流食，术前 1 天和手术当天清晨灌肠（聚乙二醇/甘露醇）01 23 个论总论结合

"o"

二、结肠癌（乙状结肠多见）

1.大体类型（左亲右拢）

①溃疡型

②**隆**起型：多为**右**侧，多有**腹部肿块和全身症状（低热、贫血、消瘦）**

缺铁性贫血概率大

右边与吸收有关

③**浸**润型：多为**左**侧，多有**梗阻（大便细）、便血**

肠子越靠近肛门越细

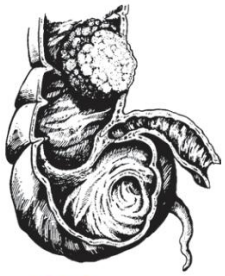


图 41-12 隆起型结肠癌

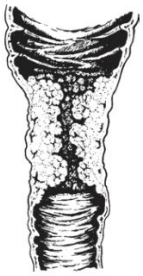


图 41-13 浸润型结肠癌

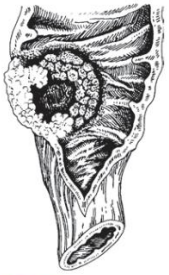


图 41-14 溃疡型结肠癌

2.根据病灶的部位（肿瘤远端距切缘≥**10**cm 师姐）

①**右半**结肠切除术 盲肠、升结肠、结肠肝曲癌

②**横**结肠切除术 横结肠中部癌

③**左半**结肠切除术 结肠脾曲、降结肠癌

④**乙状结肠**切除术 乙状结肠癌

干扰:没有升/降结肠切除术

3.结肠癌并发急性肠梗阻

①右半：**右半结肠切除、一期回肠-结肠吻合术** 右边比较干净,血供好

②左半：切除、一期吻合术，或支架置入、限期切除。若肠管扩张、水肿明显→切除肿瘤、近端造口与远端封闭

很少

水肿太明显,吻合不上

①食管癌:切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织 五八同城买食材

②胃癌:位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm 无端生事

③保乳乳腺癌切除术(切肿块+1-2cm组织)